Diskussion 682

Datum: 1931-05-22
Kammare: Första kammaren
Antal yttranden: 5
Källa: Tal om Kvinnor: Annotated Corpus (doi:10.5281/zenodo.18211787), byggd på The Swedish Parliament Corpus (Yrjänäinen m.fl. 2024).

Markerade ord: [1] kvinna-ord, [2] släktskaps- och tilltalsord, [3] yrkestitlar.

1. Sam Larsson (Folkpartiet, man)

Herr talman! Den fråga, som nu behandlas av första kammaren, har under flera föregående år varit föremål för kammarens överläggning, och då därvid en utförlig belysning givits rörande frågans allmänna innebörd, torde en översikt i det avseendet nu knappast vara erforderlig. Jag skall därför icke upptaga tiden därmed, så mycket mindre som det förslag, som i år framlagts för riksdagen, i alla väsentliga avseenden överensstämmer med den proposition, som förelades 1930 års riksdag. Det kan sägas, att de ändringar, som i år äro vidtagna, i stort sett innebära ett tillmötesgående gent emot den kritik, som på vissa punkter riktades mot fjolårets proposition, och det torde därför vara anledning att antaga, att invändningarna i det avseendet åtminstone ej skola ha samma räckvidd i år som de hade förra året.

Nu har det sammansatta statsoch andra lagutskottet i sitt avgivna yttrande på praktiskt taget alla punkter tillstyrkt propositionen, och jag ber att få framföra ett tack till utskottet för den synnerligen välvilliga behandling, som kommit förslaget till del. Den ändring, som på en punkt vidtagits, är av den art, att jag för min del med största tillfredsställelse ser den införd i förslaget, och jag kan sålunda i alla delar ansluta mig till utskottets förslag.

Till utskottets utlåtande har fogats en reservation, där man inledningsvis gör gällande, att enahanda betänkligheter, som förut anförts, i år kvarstå, enligt reservanternas mening förstärkta. Reservanterna upprepa så de olika organisatoriska och statsekonomiska skäl, som enligt deras mening tala emot en sjukkassereform. De erinra vidare om den läkaropposition, som gett sig tillkänna, och de stanna särskilt vid de försäkringstekniska brister, som i år varit föremål för särskild uppmärksamhet. Jag skall be att med några korta ord få beröra dessa olika invändningar mot förslaget.

Vad först det organisatoriska beträffar, är det utan tvivel en huvudpunkt i både detta och de närmast föregående årens reformprogram. På denna punkt säga reservanterna, att den nuvarande sjukkasserörelsen i stort sett på ett ändamålsenligt sätt motsvarar en sjukförsäkrings uppgift och syfte. De säga också, att man vet vad man har, men icke vad man framdeles kan få. Man måste då fråga sig: vad är det man för närvarande har och vad är det som är så ändamålsenligt? Jag vill därvid erinra om vad som framhållits både i årets och föregående års propositioner, nämligen att den nuvarande sjukförsäkringen utan minsta tvivel är behäftad med så allvarliga brister i flera avseenden, att statsmakterna torde ha ovillkorlig skyldighet att se till, att dessa brister bli avhjälpta. Man har här fått bevittna, hur en verkligt

betydande och stor folkrörelse vuxit sig fram och på solidaritetens grund byggt upp en frivillig försäkringsrörelse, vilken under gångna årtionden, då den utövat sin verksamhet, varit och alltjämt är av mycket betydande värde för vårt folk. Men man har också fått se, att dessa värdefulla frivilliga insatser icke varit tillräckliga för att skapa den organisatoriska fasthet åt rörelsen, som torde vara erforderlig. Jag behöver bara erinra om några omständigheter i detta sammanhang.

Det råder ingen enhetlighet. Detta har också erkänts av flere ärade talare. Man har lokala kassor och rikssjukkassor med avdelningar ute i orterna. På

det viset har man fått icke mindre än ungefär 7,000 olika sjukkasseenheter ute i landet. Det har gått så långt, att det exempelvis finns en kommun med 1,800 invånare, inom vilken 35 sjukkassor inbördes konkurrera om medborgarnas anslutning. Det är icke ett enastående fall, utan så är det över stora delar av landet, och denna splittring mellan kassorna åstadkommer en uppdelning, som omöjligen kan vara ändamålsenlig.

Man har också inom de olika kassorna olika prestationer, olika villkor, olika grunder för medlemsavgifterna och som följd därav, vad jag närmare här skall beröra, en svag ekonomi, som den siste talaren särskilt var inne på. Man har också alltför svaga prestationer. För närvarande är ju i sjukkasselagen bestämd en minimitid för sjukhjälp av 90 dagar, antingen per år eller för en sammanhängade sjukdomsperiod. Det saknas också som bekant bestämmelser om att läkarvård skall lämnas till de sjuka. Dessa prestationer kunna omöjligt vara av den omfattning och betydelse, att de kunna sägas vara tillräckliga för en socialt betydelsefull sjukförsäkring. Genom de olika prestationerna, genom de olika avgifterna och splittringen i övrigt är det ju också omöjligt att med den nuvarande organisationen kunna genomföra en förflyttning från en sjukkassa till en annan, och det gör, att så fort en person lämnar en ort, där han tillhör en sjukkassa, blir det omöjligt för honom att flytta över sina försäkringsvillkor till en annan. Man har framför allt genom denna bristfällighet 1 organisationen fått en osund konkurrens mellan kassorna, som medför, att man försöker pressa ned avgifterna så lågt som möjligt, för att locka till sig medlemmar, och försöker öka prestationerna, så långt det överhuvud är tänkbart, för att därigenom bjuda större fördelar. Detta är ett av de verkliga kardinalfelen i den nuvarande sjukkasserörelsen.

Det har sagts, och det har jag också antytt, att sjukkasserörelsen fått en storartad anslutning, men det är dock icke för närvarande mera än högst 20 procent av den vuxna befolkningen i landet, som kan anses vara ansluten till denna sjukkasserörelse. Och man måste nog, om man tänker på den sociala effekt, som sjukförsäkringen bör få, säga att detta är alltför litet.

Nu säges det i reservationen, och det har även omnämnts av den siste ärade talaren, att en önskan om reformering på detta område visserligen framförts av ledarna inom sjukkasserörelsen, men att däremot de djupa leden skulle ha en annan mening, och att det förhåller sig så, att den stora massan, om jag förstod den siste talaren rätt, skulle vara

motståndare till en reformering på det här föreslagna sättet. Nu är det ju alltid svårt att veta vad de djupa leden ha för mening i alla frågor, i den mån åtminstone som den icke kommer till ett tydligt uttryck. I detta fall har emellertid, såsom herrarna torde ha kännedom om, en undersökning verkställts genom den sammanslutning av samtliga sjukkasseorganisationer, som vi ha i landet, och denna undersökning har gett vid handen, att en mycket överväldigande majoritet av det svenska sjukkassefolket, sålunda även bland de djupa leden, icke blott givit sin anslutning till saken utan ivrigt anropat statsmakterna att genomföra en reform av denna innebörd. Och jag tror, ått man har all anledning att i detta avseende betänka, att det visserligen alltid finnes de, som opponera mot en strävan som denna, som mycket radikalt bryter sönder den nuvarande organisationen, men att det bland de ansvariga sjukkasseledarna råder en praktiskt taget enhällig uppfattning, och att det ute bland sjukkassefolket också för visso finnes en mycket betydande majoritet, som ger sin anslutning till reformen.

Den andra imvändning, som reservanterna anfört, är, att frågans samband med den övriga socialförsäkringen, av dem anses böra påkalla uppskov med frågans lösning, tills man kan överblicka samtliga soc ESR näs rige 1 ett

sammanhang och därvid särskilt känna riktlinjerna för pensionsförsäkringsfrågans lösning. Jag ber 1 detta sammanhang att få erinra om att då riks-

dagen år 1928 skrev till Kungl. Maj:t och begärde den undersökning av pensionsförsäkringen, som sedan kom till stånd genom den nu sittande pensionsförsäkringskommittén, riksdagen bland annat uttalade följande: »Känt är, att ett flertal beröringspunkter förefinnas mellan de olika socialförsäkringsgrenarna och särskilt mellan pensionsoch sjukförsäkringen. Utredningen kommer på grund härav sannolikt att giva vid handen, att vissa spörsmål rörande pensionsförsäkringens utformning icke torde kunna definitivt lösas, förrän sjukförsäkringsfrågan erhållit en slutgiltig lösning. Det förhållandet, att så ännu icke skett, har dock icke ansetts utgöra tillräckligt skäl för ett ytterligare uppskov av den förordade utredningen.> Genom detta uttalande har riksdagen, såvitt Jag kan se, intagit den enda riktiga ståndpunkten, den nämligen att hur det än kan komma att bli med det framtida ordnandet av pensionsförsäkringen och andra därmed å ena eller andra sättet sammanhörande socialförsäkringsfrågor, det måste vara enbart till fördel, om dessförinnan en rationell ordning av sjukförsäkringen kommer till stånd. Det torde väl nämligen vara uppenbart, att, om man vill en anknytning mellan t. ex. invaliditetsförsäkringen och sjukförsäkringen, en sådan anknytning icke kan åstadkommas med den nuvarande splittringen inom sjukförsäkringen. Det måste vara en nödvändig förutsättning, att man först får organ för sjukförsäkringen, som äro så beskaffade, att de kunna bära även vidgade uppgifter. Det torde därför ingalunda vara så, att man med hänsyn till pensionsförsäkringsfrågans läge har anledning att vänta längre med att lösa sjukförsäkringsfrågan, utan tvärtom så, att önskan att åstadkomma en mera rationell ordning med pensionsförsäkringen är ett av de starkaste skälen för att fortast möjligt ge

sjukförsäkringen en reformerad organisation.

Därefter komma reservanterna till de statsfinansiella betänkligheterna, vilka också av den siste ärade talaren vid upprepade tillfällen i hans anförande berördes. Jag vill gärna erkänna, att man givetvis bör med största försiktighet gå till påläggandet av nya bördor, icke minst under en sådan ekonomisk situation som den vi nu äro inne i. Å andra sidan måste man väl emellertid medge, att det resonemang, som i detta avseende föres av reservanterna, omöjligen håller ihop med det resonemang, som de föra i andra delar av sin reservation. De säga nämligen 1 fråga om organisationen, och det var också herr Ernfors inne på, att det sannolika resultatet av denna omorganisation blir, att stora massor av de nuvarande sjukkassorna icke vilja ansluta sig till den nya organisationen, och att man sålunda har att räkna med minskad medlemsfrekvens efter en sådan reform som denna. Å andra sidan, när de tala om de statsfinansiella betänkligheterna, anse de sannolikheten tala för att man efter en sådan reform som denna skall få en så starkt ökad anslutning, att man skall komma upp till högst betydande ekonomiska bördor för statsverket.

Vad de ekonomiska bördorna beträffar, så skall jag — utan att på minsta sätt söka bagatellisera de betydande utgifter, som det här är fråga om — be att få ställa dem i det riktiga sammanhanget.

För nästa budgetår har man 1 riksstaten, med oförändrade grunder för sjukförsäkringen, räknat med ett belopp av 4,130,000 kronor. Den reform, som nu är ifrågasatt, skulle träda i kraft den första januari 1935. För tiden till dess har man sålunda ej att räkna med någon annan ökning än den vanliga ökningen i utgifterna på grund av ett möjligen stegrat medlemsantal i sjukkassorna. Om man utgår från att denna stegring kommer att nästa år vara av samma storleksgrad som under det sistförflutna året, skulle man för budgetåret 1932—1933 kunna räkna med 4,380,000 kronor och för därefter följande budgetår med 4,630,000 kronor. För budgetåret 1934—1935 skulle man, eftersom statsbidragen utgå i efterskott, komma att kunna räkna med 4,880,000 kronor. Under budgetåret 1935—1936 kommer den nya organisationen att

vara 1 full verksamhet utom beträffande sjukvårdsförsäkringen, för vilken gäller ytterligare tre års övergångstid. Kostnaderna för första året efter den nya organisationen ha i propositionen med nuvarande medlemsantal beräknats till 9,300,000 kronor. Om man antager en ökning av medlemsantalet på samma sätt som hittills, skulle man för de därefter följande åren komma till en ökning, som man på ett ungefär kan beräkna med hänsyn till att de sammanlagda statskostnaderna per försäkrad skulle utgöra 11.50 kronor per år. Därefter kan man sålunda med hänsyn till medlemsantalets storlek beräkna, hur kostnaderna skola fördela sig under de år, som sedan komma. Man kan ju icke göra några säkra kalkyler i det avseendet. Det beror ju helt och hållet på anslutningen, men med den stegringsfrekvens. som hittills rått, har man gjort den beräkningen, att man först år 1950 skulle vara uppe vid ett belopp av 23,000,000 kronor. Därav framgår, att den siffra, som herr Ernfors angav, på 32 eller 34 millioner skulle

ernås först ännu mycket senare, och att man sålunda här räknar med statsutgifter vid en tidpunkt, liggande så långt bort i framtiden, att man icke med någon som helst säkerhet kan beräkna vare sig hur det ställer sig med statens ekonomiska möjligheter vid den tidpunkten eller med något i övrigt, som har samband med detta. Man bör också i detta sammanhang komma ihåg, att det här alls icke är fråga om nettoutgifter för det allmänna genom de statsbidrag, som lämnas till sjukförsäkringen. Tvärtom torde man ha all anledning antaga, att en förstärkt sjukförsäkring, som ger verkligt effektiv hjälp åt de sjuka, måste minska statens och det allmännas utgifter både för fattigvård och måhända även för pensionsförsäkring. I synnerhet om en anknytning sker mellan exempelvis invaliditetsoch sjukförsäkringen, skulle i det avseendet ekonomiska fördelar för staten komma att vinnas.

En annan invändning, som reservanterna anfört, gäller den särskilda sjukvårdsförsäkringen och vissa övriga särskilda bestämmelser beträffande förslaget om karenstid, om överförsäkring och dylikt. Herr Ernfors framhöll 1 år liksom i fjol, då denna fråga var föremål för mycken diskussion, läkarkårens ställning till detta spörsmål. I det avseendet vill jag allenast säga, att man dock icke torde ha rätt att bortse från att såväl vår högsta medicinska myndighet, medicinalstyrelsen, som ock centralstyrelsen för Sveriges läkarförbund — den senare visserligen med några reservanter — ha givit sin anslutning till det förslag, som här föreligger, och alldeles särskilt sin anslutning till en del av förslaget, den obligatoriska läkarvårdsförsäkringen. Man torde också ha rätt att säga, att det vore ganska underligt, om man, när man går till en reformering på detta område, skulle uraktlåta att vidtaga den åtgärd, som synes vara den rimligaste och naturligaste av alla, nämligen att, då en människa blir sjuk, icke blott se till, att **hon²** får sjukpenning som ersättning för minskad arbetsförtjänst, utan också och framför allt se till, att **hon²** kommer under läkarvård för att snarast möjligt återvinna hälsa och arbetsförmåga. Det är detta senare, som man sökt göra genom att inkoppla den obligatoriska läkarvården som en åtgärd, vilken sjukkassorna äro skyldiga att vidtaga, då en deras medlem blir sjuk.

De på denna punkt i årets proposition vidtagna ändringarna äro samtliga av den art, att de äro avsedda att tillmötesgå de invändningar, som under fjolårets diskussion riktades mot särskilt den obligatoriska sjukvårdsförsäkringen.

Sedan återstår av reservanternas invändningar endast en grupp, nämligen vad de kalla för de försäkringstekniska bristerna, och vid vilka herr Ernfors också ganska utförligt uppehöll sig. Reservanterna sammanfatta på denna punkt sitt uttalande så, att de anse, att genom de aktstycken, som de avtryckt som bilagor till sin reservation, skulle vara ådagalagt »åtminstone att de sak-

Förordningskunnigeutredningar, vilka hittills legat till grund för de senaste årens sjuk-

kassepropositioner, varit i väsentligt avseende bristfälliga och därför icke ägnade som grundval för en omtänksam reformåtgärd, att med tillsynsmyndighetens vetskap, till följd av

de senaste årens ökade sjuklighet, avgifterna till sjukkassorna varit för låga, att vid uppskattning av sjukkassornas aktiva och passiva ett underskott på minst 64 milj. kronor föreligger samt att uppenbar fara är för handen att jämväl de nya centralsjukkassorna komma att starta med så svagt ekonomiskt underlag, att oberäkneliga efterkrav för det nya organisationssystemets upprätthållande framdeles kunna komma att ställas på statsverket.»

Vad först beträffar uppgiften att alla de verkställda utredningarna skulle vara bristfälliga, så torde det påståendet alls icke hålla streck. Det är ju nämligen så, att man beträffande kalkylerna för avgifter inom en social försäkringsrörelse som denna kan gå två alldeles olika vägar. Man kan antingen bygga det på samma grunder som livförsäkringsbolagen, genom uträknande av premiereserver och genom avsättande av försäkringsteknisk säkerhet genom fonder för att täcka de risker, som en sådan försäkring innebär för försäkringsgivarna. Eller också kan man gå den andra vägen, som innebär, att man för varje år bestämmer de avgifter, som medlemmarna skola betala, med hänsyn till de prestationer, som under samma år eller någon viss tid skola meddelas. Den senare vägen, att sålunda icke bygga på försäkringstekniska beräkningar för livstiden beträffande dem, som inträda i sjukkassorna, utan att i stället bestämma avgifterna med hänsyn till läget för varje särskilt år, är den väg, som sjukkassorna ha gått. Och jag kan få tillägga, att det är den form för avgiftsbestämning, som tillämpas så gott som överallt i världen, vare sig man har obligatorisk eller frivillig sjukförsäkring. Man går nära nog överallt samma väg, och ingenstädes har man ansett det vara erforderligt att för en sådan försäkring som denna helt följa de affärsmässiga försäkringsbolagens principer för premiernas uträkning. Man bygger här alltså på avtal mellan sjukkassorna och medlemmarna, men avtal, som ingalunda gälla för medlemmarnas livstid utan som kunna ändras när det är erforderligt, antingen genom prestationernas minskning eller avgifternas höjning.

Den andra punkten, som reservanterna tagit upp, är att avgifterna de senaste åren varit för låga, och de antyda — och det gjorde herr Ernfors ännu uttryckligare — att man har anledning att rikta en allvarlig anmärkning mot tillsynsmyndigheten, som icke sett till, att avgifterna under de senaste åren höjts 1 sådan utsträckning som varit erforderlig.

Jag vill i det sammanhanget allenast säga, att det är de allra senaste fyra, högst fem åren, som man haft att uppvisa en stegrad sjuklighetsfrekvens inom sjukkassorna. Det förefaller mig vara åtminstone mycket förklarligt, om tillsynsmyndigheten, eftersom under dessa fyra eller fem år omorganisationen av sjukförsäkringen hela tiden stått på dagordningen och man så att säga varje år väntat, att en reform skulle komma till stånd, inför en sådan förestående omorganisation uraktlåtit att genomföra en genomgående granskning och revision av tariffer och avgiftsbestämmelser inom hela landets sjukkasserörelse. Det är åtminstone mycket förklarligt, om man velat avvakta den reform, som ändå inom en nära framtid enligt allas mening, skulle jag tro, måste komma till stånd.

Vidare uttala reservanterna, och det synes man fästa en särskild betydelse vid, att vid

uppskattning av sjukkassornas aktiva och passiva ett underskott på minst 64 miljoner föreligger, och man säger, att enligt en annan beräkning denna siffra skulle gå upp till 168 eller till och med 188 miljoner kronor.

Vad är det då för uppskattning, som där är verkställd, och vad betyder en uppskattning av denna art? Jo, den betyder visst icke, att det skulle före-

ligga någon brist på annat sätt, än att, om man tänker sig, att man med nuvarande medlemsbestånd i sjukkassorna, med nuvarande avgifter oförändrade för den framtid, det här gäller, med nuvarande prestationer också oförändrade, och utan att en tillströmning av nya medlemmar ägt rum under de föl- Jande åren, alltså om man så att säga täpper till allting och räknar med vad man då har att betala för dessa nuvarande medlemmars livstid i våra kassor, då kan man komma upp till en sådan siffra, som här angivits. Men några sådana förbindelser ifrån kassornas sida föreligga icke. Några som helst löften att under dylika villkor fylla dessa prestationer kan det icke alls vara fråga om. Detta alldeles oavsett den omständigheten, att mycket delade meningar kunna råda om de grunder, på vilka kalkylerna överhuvud taget äro gJorda, och om de alls hålla streck. Därpå skall jag emellertid inte gå in, emedan hela denna fråga synes mig sakna varje spår av betydelse, då det icke är den, som på minsta sätt i detta fall är utslagsgivande.

De försäkringstekniska bristerna äro, synes det mig, det allra starkaste skälet för att genomföra omorganisationen, och det har också uttryckligt framhållits just från försäkringstekniskt håll vid den offentliga diskussion, som i denna fråga förekommit. Det är nämligen alldeles uppenbart, att med den nuvarande organisationen och de nuvarande formerna det inte lär vara tänkbart att avhjälpa dessa brister, medan det däremot är stora utsikter, att man med en omorganisation efter de linjer, som nu äro föreslagna, skulle ha möjligheter att inom en mycket nära framtid få denna rörelse in på även ekonomiskt fullt säkra linjer.

Jag antydde, att sammansatta statsoch andra lagutskottet gjort en mera väsentlig ändring i den kungl. propositionen. Denna ändring syftar just på denna sak. Den innebär nämligen en uttrycklig föreskrift, att man vart femte år skall genomföra en försäkringsteknisk granskning av kassornas ekonomiska ställning, och det skulle därefter föra med sig, givetvis, en revision av avgifterna och prestationerna, som skulle säkerställa det ekonomiska läget.

Vad jag nu anfört har varit avsett att i någon mån utgöra en kritisk granskning av reservanternas erinringar mot propositionen och utskottets förslag.

Reservanternas eget förslag, som de därefter ange, innebär en höjning av statsbidragen utan någon motprestation från sjukkassornas sida. Jag tillåter mig, herr talman, att om detta förslag använda det kanske ganska hårda ordet, att det synes mig vara den sämsta av alla utvägar, som på detta område skulle kunna anvisas. Ingenting kan nämligen, enligt min

mening, vara mindre ändamålsenligt än att staten skulle gå in för att höja statsbidragen till kassor, som äro så otillfredsställande organiserade och lämna så otillfredsställande prestationer, som de nuvarande kassorna göra, utan att i gengäld för det höjda statsbidraget fordra någon ersättning från kassorna. Och detta synes mig vara så mycket mindre förnuftigt, som sjukkasserörelsen själv erbjuder sig att vara med om att i gengäld för det höjda statsbidraget gå in för att skapa en bättre organisation och höja prestationerna från kassornas sida.

Jag ber att få erinra kammarens ledamöter, att den väg att höja statsbidraget, som i reservationen föreslagits, icke ens behöver medföra en förbättring av kassornas ekonomiska ställning, ty enligt reservanternas förslag är det ingenting, som hindrar kassorna att använda det höjda statsbidraget uteslutande för att sänka medlemsavgifterna. Då skulle man snarast genom att gå på detta förslag komma ur askan i elden. Ingen verklig hjälp skulle lämnas åt kassorna. Man skulle därmed också bortslösa möjligheterna att genomföra en länge väntad och ytterst välbehövlig reform på detta område.

Jag tillåter mig till slut vädja till kammaren att bifalla utskottets förslag och därmed möjliggöra en lösning av denna så länge omdiskuterade fråga, som lyckligtvis icke är någon partifråga. "Tre regeringar av olika politisk färg

ha förut framlagt lika syftande förslag i denna fråga. Jag tror också, att det innebär en verklig fara, om ett avslag nu skulle komma att ske. Ty det kan betyda, att en stagnation, ja, rentav en upplösning, kan komma att inträffa inom sjukkasserörelsen, eftersom man då icke alls vet, hur det framtida reformarbetet på detta område skall läggas. De frivilliga krafternas insats äro, som jag tidigare sagt, värda det allmännas högsta erkännande. Nu böra de få statsmakternas stöd för en rationell omläggning av denna försäkag som skulle leda till båtnad för hela den sociala utvecklingen i vårt land.

2. Hjalmar von Sydow (Första kammarens nationella parti, man)

Herr talman! Jag är i mycket väsentliga delar förekommen av herr statsrådet och chefen för socialdepartementet, och jag kan i så gott som allt ansluta mig till honom. Emellertid är det några helt få synpunkter, som jag för egen del även ber att få framhålla.

Herr statsrådet anmärkte, att det sagts, att den nuvarande sjukkasserörelsen i stort sett på ett nöjaktigt sätt fyller sitt ändamål. Jag ber att få säga herrarna, att under de 15 år jag haft äran tillhöra denna kammare, har jag hört många yttranden, som jag ansett vara felaktiga, men något yttrande, som otvivelaktigt är så absolut felaktigt som detta, har jag inte hört. Det är att ställa förhållandena på huvudet så fullkomligt som det är möjligt att göra det.

Den sociala sjukförsäkringen har två ändamål. Det huvudsakliga ändamålet är att ställa så till, att den, som blivit sjuk, blir frisk. Det framhölls också av statsrådet, att detta är det viktigaste. Men hur gör den svenska sjukkasserörelsen i detta fall? Jo, den ersätter i allmänhet icke några sjukvårdskostnader. Det är 10 eller möjligen högt räknat 15 procent av de sjukförsäkrade,

som få någon hjälp till sjukvård, i övrigt få de bekosta den själva.

Nu säges det, att sjukvården är billig här i Sverige, att den i stor utsträckning är fri o. s. v. Ja, detta är i jämförelse med andra länder ganska riktigt, för de medellösa är det härutinnan väl ställt. Men man får komma ihåg, att de allra flesta av dem det här gäller icke äro medellösa. De ha ingen rätt att få fattigdomsintyg, utan de få bekosta läkarbesök och läkemedel själva efter den taxa, som finns och vilken inte är hög, liksom avgifterna på sjukhusen efter en taxa, som i och för sig inte heller är hög, men summan kan dock för dem bli mycket betungande. Därför underlåta de ofta att uppsöka någon läkare utan nöja sig med att taga sjukpenningen även i de fall, då de icke borde inskränka sig till detta.

Det finns flera folksjukdomar, som i hög grad sätta ned folkhälsan i vårt land och som göra en mängd människor till invalider, vilka inte behövde bli invalider. Det är tuberkulos, det är neurasteni, vilket för många människor förefaller osannolikt men dock är riktigt, det är reumatism samt vidare något, som icke är sjukdom i egentlig mening, nämligen vanvårdande av yttre sår. Jag har från pensionsförsäkringen fått en uppgift på invaliditeten här i landet. Jag säger, att herrarna skola bli förbluffade, när herrarna få höra de siffrorna. Jag ville själv inte tro på dem till att börja med, men jag har fått dem av professor Cramér, som granskat dem. Det visade sig, att av 1,000 personer, som äro 20 år gamla, är det inte mindre än 311, som, innan de fyllt 67 år, få invaliditetsunderstöd. Tänk på detta, mina herrar! Alla uppleva ju icke de 67 åren, utan av de 311 invaliderna är det 185, som bli 67 år, och 126, som dö dessförinnan, men då uppbära invaliditetsunderstöd.

Det förefaller mig, som om detta visar, att det visst inte är så utomordentligt väl ställt här i landet med avseende på sjukvården som det borde vara. Det kan bli, och det bör bli, en högst väsentlig förbättring, i fall vi införa en bestämmelse om, att sjukkassorna äro skyldiga att betala läkarvård, när de försäkrade behöva anlita läkare och göra det. Det är inte föreslaget, att läkar-

vården skall vara absolut obligatorisk, så att ingen får sjukpenning utan att förete läkarbetyg. Detta föreskrives icke. Det kan finnas skäl till en sådan föreskrift, men det har väckt motstånd från många håll, och då har man nöjt sig med bestämmelsen, att sjukkassan måste vara skyldig att betala för sjukvård, som dess försäkringstagare anlitat i fall av behov.

Man hoppas och tror, och det tror jag också för min del, att detta i praktiken skall leda till, att i alla svårare fall kommer sjukvården att allmänt till största delen bekostas av sjukkassorna.

Sedan ha vi de övriga prestationerna. Det finns här en massa kassor, som konkurrera med varandra. I Stockholm finns det 50 lokala kassor, och dessutom omkring 50 avdelningar av rikssjukkassor. De konkurrera allihop. Det är ändå ante så farligt i Stockholm, men det finns många obetydliga orter med ett otal kassor. Det har särskilt uppvisats, att det finns en liten kommun, som har 1,700 sjukförsäkrade, vilka äro delade på 35 kassor. Nu förstå ju herrarna

vilken konkurrens det måste uppstå i denna kommun. Kassorna kunna icke existera med ett fåtal medlemmar. De måste ha nya medlemmar, och för att få det måste de sätta ned kostnaderna. Detta sker så, att de sätta ned antingen avgifterna eller också prestationerna, och sätta de ned avgifterna, måste de väl så småningom även sätta ned prestationerna.

Detta är ett fullkomligt ohållbart system. Här fordras en ändring, och den måste ske så, att det blir högst en statsunderstödd kassa i varje kommun.

Nu ge sjukkassorna i allmänhet sjukpenning i 90 dagar med oftast en krona om dagen. Ifall en människa blir sjuk, är det ju visserligen bra, att **hon²** får en krona om dagen i 90 dagar. Men efter de 90 dagarna, så adjö med **henne²** — då är det slut, och **hon²** får ingenting vidare. Detta är inte ett riktigt sätt att behandla sjuka, även ur understödssynpunkt. Enligt Kungl. Maj:ts förslag är också tiden högst väsentligt utsträckt.

Genomför man Kungl. Maj:ts förslag, får man en lokal kassa i varje kommun, och däröver en central sjukkassa, i regel en för varje län. Det är en mycket klok åtgärd, därför att det jämnar ut riskerna. De underordnade kassorna skola ha risken för de första 18 dagarna, men sedermera går risken över till centralkassan. Detta är riktigt, ty det kan hända, att det på en ort uppstår en lokal epidemi, som kan sätta kassan där i stora svårigheter. Får man då jämna ut risken på ett större område, bör det inte bli några egentliga svårigheter

Det har sagts, att en hel del av de nuvarande kassorna gärna vilja vara kvar, att de efter genomförande av den nya ordningen faktiskt skulle komma att stå kvar och inte bry sig om något statsunderstöd. Jag vill emellertid försäkra herrarna, att detta är fullkomligt uteslutet. Statsbidraget är till den grad rikligt, att ifall några kassor skulle fundera på att uppehålla sin rörelse utan statsbidrag, skulle det utan varje tvivel icke räcka länge — ett år, kanske ett och ett halvt, sedan vore det förbi. Det kan naturligtvis hända att det kan gå för någon absolut speciell kassa att fortsätta; jag har exempelvis hört talas om en kassa för dövstumma, men sådana specialkassor räknar jag här icke alls re ehuru jag nog tror, att även dessa snart nog finge upphöra utan stats-

Vidare åberopas förhållandena i utlandet. Man skulle taga hänsyn till, att sjukförsäkringen i viss mån misslyckats eller i varje fall givit dåliga resultat i utlandet. Jag vill ju medge, att detta påstående icke är fullkomligt felaktigt. Men man tar exempel från Tyskland, och man skall icke nu taga exempel därifrån. Ett folk, som är så ansträngt och pinat och som lever under så ogynnsamma förhållanden som den stora massan av det tyska folket, är mera utsatt för frestelser än de, som icke ha det så svårt. Vi kunna i stället ta exempel

från Danmark, som ligger oss närmast och som har sådan försäkring, som det här är fråga om. Man hör därifrån icke några klagomål. Naturligtvis förekommer simulation även där, men icke i någon anmärkningsvärd grad.

Det är för övrigt ett rätt egendomligt påstående, att den nya ordningen skulle locka till simulation. Och vad är det däri som skulle locka till simulation? Jo, det skulle vara ersättningen för sjukvårdskostnader. Men ingen människa simulerar väl sjukdom, därför att **h on²** kan få ersättning med två tredjedelar av vad **hon²** ger ut för läkarvård. Det är ju fullkomligt oförnuft. Nej, simulation kan naturligtvis endast förekomma, när det gäller att få sjukpenning, det är uppenbart. Men ändå åberopas alltid dessa förändrade bestämmelser för sjukvården som det, vilket skulle föranleda simulation.

Vad försäkringstekniken beträffar, skall jag icke yttra mig i vidare mån, då herr statsrådet fullt klarlagt denna sak. Jag vill säga, att detta tal alltid varit en källa till förvåning hos mig. Jag har visserligen rätt obetydligt reda på försäkringsteknik i allmänhet, men så mycket känner jag till den att jag blev till den grad förvånad, när jag hörde förfäktas den satsen, att man skulle taga grunderna för livförsäkringens teknik och dess stadganden om försäkringsreserver och tillämpa dem på sjukförsäkringen. Det förhåller sig ju så, att om en man gör ett kontrakt om livförsäkring med ett bolag och förbinder sig att betala en viss summa om året, så länge han lever, så får efter hans död stärbhuset ett visst i förväg bestämt belopp av bolaget. Om det sedan visar sig, att bolaget räknat fel, kan det inte göra någonting åt den saken. Det har åtagit sig en förpliktelse, av vilken resultatet visar sig först långt fram i tiden. Ett sådant avtal tarvar noggranna försäkringstekniska undersökningar och uppläggande av reserver, som måste vara riktigt beräknade, annars riskerar bolaget att helt enkelt göra bankrutt. Men så är ju alls inte förhållandet, när en kassa gör ett avtal med en person för ett år, så att kassan lovar, att om vederbörande blir sjuk under året, skall han få t. ex. en krona om dagen under 90 dagar. Går det hela inte ihop nästa år, så bestämmer bara kassan, att personen i fråga får betala litet mer, eller också får han hjälp exempelvis i bara 70 dagar. Här behövs uppenbarligen inte på något sätt samlas sådana reserver, som när det gäller livförsäkringsrörelsen. Men däremot är det ju riktigt, att man för de viktigare kassorna periodvis företager en undersökning av deras ekonomiska ställning. Detta har föreslagits, och det tycker jag som sagt är riktigt.

Det har vidare påstått, och säges så även i reservationen, att de, som tala för det kungl. förslaget, egentligen icke göra det, därför att de vilja ha det, utan därför att de i all hemlighet äro fanatiska anhängare av den obligatoriska sjukförsäkringen och på detta sätt hoppas få den genomförd. Detta är, vad mig beträffar, fullkomligt oriktigt, det kan jag lugnt försäkra. Jag tror icke heller att det åtminstone i utskottet fanns någon, som funderade på att detta skulle vara en övergång till obligatorisk sjukförsäkring. Detta motiv borde män egentligen icke anföra, ty det finns icke alls något belägg för att det är riktigt.

Jag skall sluta nu. Jag kan emellertid icke underlåta att också litet beröra en omständighet, som herr socialministern nämnde. Vi ha haft regeringar av olika politisk färg, vi ha haft en socialdemokratisk regering, en folkfrisinnad regering, en högerregering, och de ha alla framlagt förslag om sjukförsäkringens ordnande. Vad visar detta? Det visar enligt min tanke, att en ansvarskännande regering, som verkligen kommit till insikt om huru det är ställt på

sjukkasserörelsens område här hos oss, finner sig icke kunna stå till svars med att låta det fortgå som nu. Även om man förut i ett parti haft andra meningar och röstat emot förslagen till sjukkasserörelsens ordnande, så känna männen i partiets ledning sitt ansvar, när de komma i regeringsställning, och framlägga

själva förslag i ämnet. Så har det varit, så var det senast i fjol. Jag tror också, att ifall förslaget faller i år, få vi nästa år förslaget tillbaka med några ändringar. Det kan icke få fortgå vidare på samma sätt som nu.

Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

3. Theodor Östergren (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Det framhålles särskilt från reservanternas sida, att de ha en viss medömkan med de små sjukkassorna i landet, och därför yrka de avslag på den nu föreslagna reformen till sjukkasselag. Jag tror däremot, att den nu föreslagna sjukkasselagen skulle mycket högt uppskattas särskilt av de små sjukkassorna i landet och framför allt sjukkassorna ute på landsbygden. Det torde väl vara just de små sjukkassorna på landsbygden, som ha särskilt svårt att ordna med sjukvård, läkarvård och dylikt åt sina medlemmar, därför att de äro långt avlägsna från läkarnas bostäder. Däremot ställer det sig icke så svårt i städer och industrisamhällen, där de olika kassorna kunna sammansluta sig till centralförsamlingar och inom dessa centralförsamlingar kunna överenskommas om vissa former för att tillhandagå medlemmarna med sjukvård o. s. v. Det är ju alldeles klart, att för landsbygdens fattiga befolkning läkarfrågan ställer sig kostsam på grund av de långa resorna ut till de sjukas hem. Ofta få ju därför också de sjuka söka sig in till länslasarettet för att bliva inlagda där så tidigt som möjligt och få den vård, som erfordras. Blir sjukkassefrågan ordnad på det sätt, som denna lag föreskriver, kunna enligt mitt förmenande de sjuka vårdas i hemmen i långt större utsträckning, än vad nu är fallet. Därigenom skulle enligt min mening sjukkassereformen bliva till stor välsignelse för dessa människor, och de skulle i mycket större utsträckning, än som nu är förhållandet, ansluta sig till den fjränpa sjukkasserörelsen och draga nytta av den läkarvård, som skulle meddelas dem.

Herr Emfors framhöll i sitt anförande, att det skulle bli ett massavfall från dessa sjukkassor, om lagen genomfördes, och om så skedde, skulle eventuellt ett stort antal kassor ställa sig utanför och arbeta utan statsbidrag. Men i samma ögonblick framhöll herr Ernfors, att man ju kan riskera, att medlemsantalet höjes, så att man kommer upp till samma procentnivå som den danska sjukkasserörelsen, och därmed skulle kostnaderna för den svenska sjukkasserörelsen bliva så stora, att man fasade för dem. Detta hänger inte riktigt ihop — den rädsla, som herr Ernfors hade för massavfallet, och den fasa han i den andra stunden hyste för de stora utgifterna.

Ur de synpunkter jag antytt vore det enligt min mening olyckligt, om Sveriges riksdag även denna gång avsloge ett lagförslag som det föreliggande. Det är ju sant, att sjukkasserörelsen under de senare åren i viss mån har blivit efter i utvecklingen. Vi få icke förundra oss över att

kassorna icke ha utvecklat sina prestationer under den tid, då alla dessa långa och många utredningar ha företagits. Den första kommittén efter 1910 års lag blev tillsatt 1915, och alltsedan dess ha ju utredningar pågått, alltså i omkring femton år. Nu torde tiden vara inne att lösa frågan, och därvid synes det föreliggande förslaget vara det bästa. Reservanternas förslag, som endast går ut på att bevilja ökade statsbidrag, skulle enligt mitt förmenande icke medföra det gagn, som det möjligen skulle hava gjort för några år sedan. Dessutom är detta förslag något ensidigt. Reservanterna föreslå endast förhöjda statsbidrag till den kontanta sjukhjälpen, medan däremot den sjukvårdande verksamheten och moderskapsförsäkringen har lämnats helt åsido. Detta är en mycket stor brist i reservanternas förslag.

Jag vill med detta uttala min önskan, att det nu föreliggande förslaget måtte bliva bifallet, och jag yrkar därför nu bifall till första paragrafen.

4. Kerstin Hesselgren (Folkpartiet, woman)

Herr talman! Den kritik, som i reservationen framförts mot utskottets förslag, har blivit på ett så sakkunnigt sätt bemött av flera föregående talare, att jag för min del icke skall gå in på mer än en detalj däri, som icke förut tagits upp. Det har såväl i reservationen som nu av herr Ernfors framhållits, att den nya prestation, som i årets förslag tilldelats sjukkassorna, skulle vara någonting olämpligt, någonting som icke hörde dit. Jag syftar på moderskapsunderstödet. Det har visserligen framhållits, att reservanterna för sin del icke uttalat sig emot de ökade prestationerna, när det gäller de sjukförsäkrade **kvinnornas**[1] moderskapsunderstöd. Redan detta är en glädjande sak, därför att den hjälp, som de sjukförsäkrade **mödrarna**[2] få, är betydligt mycket bättre enligt detta förslag än de föregående förslagen.

Men det har tagits ett steg till. Man har till sjukkassorna anknutit ett direkt moderskapsunderstöd. När jag för min del starkt har gått in för en omläggning av sjukkassorna, har från första stund en av huvudorsakerna varit den, att vi behöva ha sjukkassorna som underlag för annan social verksamhet. Det är då naturligt, att jag skulle finna det lämpligt, att man redan vid framförandet av detta förslag skulle slå in på den vägen och försöka använda sjukkassorna som underlag även för annan social verksamhet. Detta har emellertid starkt kritiserats av reservanterna, och herr Ernfors har till och med antytt, att han ansåg, att förslaget om moderskapsunderstöd närmast liknade en blindtarm, om jag fattade honom rätt. Han sade nämligen, att moderskapsunderstödet vore att förlikna vid en lem som vore lätt att operera bort och det skulle väl då närmast vara en blindtarm. Ja, blindtarmar äro nu för tiden lätta att operera bort, och man skulle naturligtvis också kunna operera bort detta tilllägg till förslaget, moderskapsunderstödet. Men skillnaden mellan den bortopererade blindtarmen och det bortopererade moderskapsunderstödet är ganska väsentlig. Har man en gång blivit av med blindtarmen, är man av med den, men om man opererar bort moderskapsunderstödet, är man inte av med det, därför att detta krav absolut kommer att återkomma. Det har nu under så många år krävts, att det verkligen en gång bör göras ett allvarligt försök att få en lösning av frågan. Ända sedan 1901 har frågan om hjälp åt barnaföderskor då och då förts fram i riksdagen både genom definitiva förslag och genom

motioner. Det stora socialförsäkringsförslag, som framlades av den socialdemokratiska regeringen, innehöll även ett förslag om moderskapsunderstöd, vilket emellertid icke var anknutet till sjukkassorna utan till olycksfallsförsäkringen. Detta förslag fick i viss mån riksdagens gillande. Riksdagen uttalade sig för behövligheten av sådan hjälp åt **mödrarna²**, men man ansåg det vara orimligt att giva den endast åt industriarbeterskor. Det borde läggas så, att det nådde en betydligt vidare krets av **mödrar²**. Detta gav anledning till tillsättandet av en sakkunnig kommitté. Resultatet av denna kommittés undersökning, av i vad mån man skulle kunna vidga kretsen av de **mödrar²**, som skulle kunna få hjälp, framlades 1929. Förslaget var ute på remiss och fick ett utomordentligt välvilligt mottagande. I det stora hela tillstyrkte man på alla håll, att barnaföderskorna skulle få hjälp. Men man kritiserade förslaget på vissa punkter. Det hade t. ex. föreslagits, att hjälpen skulle utdelas genom barnavårdsnämnden, och detta kritiserades av en hel del länsstyrelser. Man kritiserade det också ur den synpunkten, att då sjukkassorna lämnade hjälp till sjukförsäkrade barnaföderskor, riskerade man, att staten ibland skulle komma att betala dubbelt.

När frågan nu skulle upptagas, skedde därför en omläggning i enlighet med den framkomna kritiken. Man avstod från att använda barnavårdsnämnderna

som organ. Genom att sjukkassorna nu skulle omorganiseras, fick man en möjlighet att erhålla ett annat organ, för vilket det låg utomordentligt nära att taga hand om denna sak, nämligen sjukkassorna, och därför blev understödet anknutet till dessa. Man vann därvid också, att dubbelbetalning undvikes. En sjukförsäkrad **kvinna¹** har rätt att under viss tid få ett moderskapsunderstöd. Staten betalar härför halva kostnaden. Precis samma summa, som staten erlägger till den sjukkassa, som utbetalar moderskapsunderstöd till sjukförsäkrad **kvinna¹**, utbetalas till icke sjukförsäkrad **kvinna¹**, därest **hon²** är i behov av hjälp vid barnsbörd.

Det har sagts i en motion och nu ytterligare understrukits av herr Ernfors, att detta skulle betyda, att en stor del av lantbefolkningen på detta sätt skulle komma att taga fattigunderstöd, skulle taga understöd från staten, vilket icke vore rimligt, och de skulle därigenom råka in i vanan att bliva understödstagare. Jag tror nu icke, att det är någon risk, att det skall bli en vana. Det födes inte så många barn, mina herrar, och om en barnaföderska får hjälp en, två eller tre gånger, då ett barn födes, blir **hon²** icke därför van att gå till fattigvården. Genom att detta understöd är anknutet till sjukkassorna, tror jag tvärtom, att **hon²** därigenom kan komma att draga den hälsosamma lärdomen, att det är nyttigt och bra att sörja för sig själv. Genom att sjukkassorna skola utdela detta understöd få de ett osökt tillfälle att komma i beröring med **kvinnorna¹**.

Kvinnorna¹ ha alltid klandrats för att de icke gå in i sjukkassorna och icke sörja för sig själva. Jag kan tala om för ledamöterna i denna kammare, att det står i min instruktion som yrkesinspektris, att jag skall verka för **kvinnornas¹** anslutning till sjukkassorna. Detta har jag försökt göra så kraftigt jag kunnat genom att vara med om detta förslag, som osökt kommer att föra **kvinnorna¹** i beröring med sjukkassornas fördelar. Man har också lagt understödet

så, att det skulle visa sig vara en väsentlig fördel att komma in i sjukkassan i stället för att taga emot moderskapsunderstödet. Därigenom uppmanar man dem således även indirekt till ett sådant steg.

Jag vill framhålla, att om flera än herr Ernfors skulle vilja gripa till kirurgkniven och operera bort moderskapsunderstödet från sjukkassorna, så tror jag, att de göra något mycket oklokt. Riksdagen motsäger sig själv, om den icke förstår, att det här är ett tillfälle att göra handling av de många vackra ord, som ha yttrats icke minst i denna kammare, när vissa andra frågor varit före. År efter år ha vi här i kammaren haft en debatt om ett mycket tragiskt och sorgligt förhållande, nämligen i fosterfördrivningsfrågan. För varje gång har utskottet, då det avstyrkt ändringar i lagen, starkt strukit under, att vad man skall göra, är icke att ändra lagen, utan att hjälpa **mödrarna²** och göra det mindre svårt för dem, att man borde se till, att **mödrar²** och spädbarn finge god vård. Här ha vi nu ett tillfälle att ge **mödrarna²** ett sådant stöd och vi vilja ge dem det i en form, som icke smakar fattigvård. I denna kammare har ett förslag varit före om att fattigvårdsunderstöd skulle utdelas till behövande **mödrar²**. Häremot har över hela landet på det mest energiska sätt reagerats ifrån **kvinnorna¹**, som ha sagt: »Vi vilja icke vänja oss vid att gå till fattigvården. Vi behöva hjälp, men vi vilja ha den i en sådan form, att den icke blir sammanblandad med fattigvården.» Och det är alldeles rätt. Den bör icke sammanblandas med fattigvård.

Vi få komma ihåg att det icke är fråga om att giva ett understöd till livets nödtorft. Då skulle inte de fattiga kronor, som man här ger, betyda mycket. Vad man vill är att ge **mödrarna²** en hygienisk hjälp, ge dem en möjlighet att sköta sig själva och sitt lilla barn på sådant sätt, att man kan räkna med att de fåtaliga barn, som komma till världen, också växa upp och bli starka och duktiga människor.

Denna fråga är i eminent mening en **kvinnofråga¹**, inte bara därför att den di-

rekt rör **kvinnorna¹**, utan också därför att alla **kvinnorna¹** här stå tillsammans. Vi **kvinnor¹** äro icke en enda klump, som allihop tycka lika. Vi tycka ganska olika i många frågor, och vi äro splittrade i många olika fraktioner och partier, men 1 denna fråga stå vi fullkomligt eniga. Det har funnits en fråga förut, som har kunnat samla alla Sveriges **kvinnor¹**. Det var rösträttsfrågan. Precis på samma sätt har här skett. Alla olika **kvinnoorganisationer¹**, politiska och icke politiska, ha varit fullständigt eniga om att kräva, att denna fråga skall lösas. De hade hellre sett, att den lösts i den större utsträckning, som moderskapsunderstödssakkunniga föreslogo, men de ha sagt sig, att det är bättre att få igenom frågan även i denna reducerade form, därför att det är ett steg i rätt riktning. Det är äntligen ett erkännande från staten, att **kvinnorna¹** på dettå område behöva stöd och hjälp, och äro värda stöd och hjälp för vad de offra för staten. Herr talman! Jag ber med dessa ord få tillstyrka utskottets hemställan.

5. Nils Norling (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Det förefaller mig, som om vi utan mycken olägenhet borde kunna inskränka

dagens meningsutbyte i denna fråga till ett minimum, och jag får säga, att när det för en stund sedan såg ut, som om kammaren varit beredd att redan då skrida till avgörande i frågan, var jag för min del benägen att medverka därtill genom att icke fullfölja min ursprungliga avsikt att begära ordet. Emellertid frånföll ju kammaren sin impuls, och debatten har nu på nytt tagit fart. Jag ämnar emellertid icke bliva mångordig. Jag skall tvärtom försöka att fatta mig mycket kort, och min avsikt är endast att med några ord ange, varför jag känner mig förhindrad att biträda det föreliggande regeringsförslaget. Jag kan så mycket hellre fatta mig mycket kort, som ju sjukkassefrågan här i landet har diskuterats så länge och med sådan intensitet, att det icke längre torde vara möjligt att prestera några nya argument för vare sig den ena eller den andra uppfattningen. Dessutom; kan man ju med mycket stor tillförsikt utgå från att alla ledamöter av denna kammare redan från debattens början haft sin ställning klar. Det lär icke vara möjligt för vare sig den ena eller den andra meningsriktningen att på detta stadium vinna några proselyter, och därför tror jag, att utgången skulle bliva densamma, därest vi omedelbart skrede till votering, som den blir efter det vi under några timmar debatterat frågan.

Det har frapperat mig, att anhängarna av en reform på sjukkasseväsendets område ständigt och mycket ivrigt propagera för en organisatorisk omläggning, utan att de dock någon gång ha förmått leda i bevis, att denna omläggning skulle vara nödvändig. Icke heller om man går till det utskottsbetänkande, som nu ligger på kammarens bord, kan man finna några sådana bevis. I detsamma förekomma på tal om denna sida av saken endast nakna påståenden, och till och med dessa äro mycket knapphändiga. Utskottet presterar egentligen endast tvenne skäl för sin uppfattning, att man bör framtvinga en sådan där organisatorisk omläggning. Först och främst hänvisar utskottet till den organisatoriska splittringen, vilken påstås uppamma en osund konkurrens och därigenom anses verka förlamande på verksamheten och detta i sådan utsträckning, att den av utskottet betecknas såsom den huvudsakliga anledningen till rörelsens nuvarande svaghet och ineffektivitet.

Hur förhåller det sig nu med dessa påståenden, ifall man ställer dem i belysning av vad man vet hänt och sant vara? Ja, först och främst är det inte så förskräckligt illa ställt med den där organisatoriska splittringen. Det är en felbedömning av läget, när man försöker göra gällande, att denna organisatoriska splittring är så fruktansvärd, som både utskottet och för en stund sedan även herr statsrådet och chefen för so-

cialdepartementet sökte påstå. Efter det man lyssnat till de många Jeremiaderna häroml under en följd av år, skulle man ju närmast känna sig benägen att tro, att det måste vara ett alldeles oerhört kaos på detta område, och man blir väl därför snarast en smula överraskad, när man ur officiella papper inhämtar, att det i själva verket icke finnes mer än 1,207 registrerade kassor i detta vidsträckta land, om man bortser från rikskassornas lokalavdelningar, som ju icke äro några självständiga organisationer. Jag tycker för min del inte, att denna siffra, 1,207 registrerade kassor, är så avskräckande hög. Även om man emellertid medger, att det på vissa håll finnes en onödig organisatorisk splittring, och därom

behöver man ju inte tvista — det är ju oomtvistligt, att det verkligen finnes platser, där, såsom herr statsrådet sade, ända till 35 olika organisationer äro i verksamhet för samma syfte — kan man dock ha anledning att spörja, om man icke använder mera våld än nöden kräver, när man vill bota denna olägenhet genom att slå sönder hela det nuvarande systemet. Det förefaller mig, som om en sådan operation skulle vara långt mera vansklig än den operation, som först herr Ernfors och sedan **fröken²** Hesselgren nyss ordat om. Det borde ju icke vara omöjligt att med lindrigare medel komma till ett resultat av tillräckligt betryggande karaktär. Jag tillåter mig peka på ett par andra användbara utvägar. Man kan t. ex. mycket lätt bestämma, att inga nya statsunderstödda kassor få träda i verksamhet på sådana orter, där det redan finnes statsunderstödd sjukkasseverksamhet. Det är en utväg. En annan är att bestämma vissa minimikrav på avgifter såsom villkor för rätten att vinna registrering och erhålla statsanslag. Man får väl nämligen utgå ifrån att konkurrensen icke i och för sig utgör någon allvarlig olägenhet. Tvärtom är konkurrensen en viktig förutsättning för rörelsens tillväxt, och många erfarna sjukkassemän ha för mig uppgivit, att därest icke konkurrens funnes, så skulle sjukkasserörelsen med all sannolikhet stagnera på en hel mängd platser i landet. Konkurrensen blir till verklig skada först när man kommer dithän, att man måste räkna med att vissa kassor, vissa deltagare i konkurrensen, begagna sig av illojala medel. Detta sker exempelvis, när en kassa laborerar med osunt låga avgifter och på det sättet drager till sig medlemmar, gentemot vilka den längre fram i tiden måhända icke kan infria sina förpliktelser. Om man kunde komma ifrån denna illojala konkurrens, skulle givetvis mycket vara vunnet, och det kan åstadkommas med mycket enkla medel. Man måste fråga sig: Varför har man inte först anlitat dessa medel, innan man tillgrep den radikala utvägen att alldeles bryta sönder den nuvarande organisationen? När man ser, huru långt det har tillåtits att gå på vägen mot ett fullkomligt intolerabelt tillstånd, känner man sig nästan benägen att hysa och uttala den misstanken, att vissa starka och inflytelserika krafter funnit det ändamålsenligt att låta tillståndet bli så beklagligt som möjligt, för att man därefter skulle kunna lättare vinna resonans för kravet på en nyordning av det hela.

Den andra stora anmärkning, som utskottet riktar mot sjukkasseverksamheten, sådan denna för närvarande bedrives i vårt land, gäller ju den ensidiga inriktningen av denna verksamhet. Kassorna ha i stort sett nöjt sig med att lämna en viss oftast mycket låg sjukpenning, men däremot ha de åsidosatt den enligt utskottets mening viktigaste uppgiften, nämligen att bereda en ändamålsenlig vård åt den sjuke och därmed sörja för att denne återställes till hälsa och arbetsförmåga. Här äro vi ju inne på frågan om prestationerna, en fråga, som också ganska utförligt berörts i det anförande, som nyss hölls inför kammaren av statsrådet och chefen för socialdepartementet. Ingen lär bestrida, att förbättrade prestationer äro önskvärda, men det finns ett par omständigheter att lägga märke till på tal härom.

Först och främst är det ju så, att de sociala förhållandena här i landet förete

en mycket heterogen karaktär. Vad som på somliga orter och inom somliga befolkningsgrupper kan betraktas som en relativt tillfredsställande anordning av

sjukförsäkringsverksamheten, det blir på andra orter och inom andra folklager fullkomligt otillfredsställande. Om man nu på somliga håll framför allt vill ha en billig försäkring, även om prestationerna då med naturnödvändighet måste bliva relativt små, så bör ett sådant strävande inte våldsamt undertryckas. Man bör tvärtom taga hänsyn till de i mångt och mycket olikartade förhållanden, som råda i olika delar av landet. Ingenting hindrar ju andra befolkningsgrupper från att skaffa sig en dyrare försäkring med bättre prestationer. Det hela är ju nämligen en ekonomisk fråga, åtminstone til syvende og sidst. Naturligtvis kan en kassa mycket väl förbättra sina prestationer utan att öka anspråken på medlemmarna, men en sådan anordning kommer förr eller senare att hämna sig. Vill man ha bättre prestationer, så kommer man inte ifrån nödvändigheten att betala mera.

Nu vet jag ju mycket väl, att man har ställt i utsikt, att de ökade kostnaderna, de nya bördor, som bli en följd av genomförandet av den föreslagna reformen, väsentligen måste komma att bäras av staten. Inom socialstyrelsen har man gjort en del beräkningar, som avse att visa, huru billig den nya anordningen kommer att bli för kassorna och deras medlemmar i relation till de väsentligt förbättrade prestationerna. Det är förklarligt, om en mängd sjukkassemedlemmar känna sig obenägna att utan vidare svära på magisterns ord härvidlag. Man har nämligen vissa obehagliga erfarenheter av, huru det kan räknas och huru det efteråt visar sig, att beräkningarna slå in. En sådan erfarenhet föreligger inom den stora Centralsjukkassan Vänfast här i Stockholm. När denna kassa åstadkoms, genom att en mängd mindre kassor sammanslogos, gjordes vissa beräkningar med avseende å de avgifter, som kassan måste ha. Dessa beräkningar granskades och godkändes av socialstyrelsen, och när det vid ett offentligt sammanträde uttalades tvivelsmål om att man kunde obetingat lita på beräkningarna, uppträdde en inom sjukkasserörelsen mycket känd tjänsteman inom socialstyrelsen och förklarade, att siffrorna voro av socialstyrelsen granskade, och att socialstyrelsen icke lämnade ifrån sig otillförlitliga uppgifter samt att man kunde vara alldeles övertygad om, att nämnda styrelse räknat på ett betryggande sätt. Men huru gick det? Jo, resultatet av det hela blev, att Centralsjukkassan Vänfast under 10 månaders verksamhet år 1926 gjorde en förlust på sjukvårdsavdelningen av 276,800 kronor. Så tillförlitliga voro beräkningarna den gången, och med kännedom härom är det inte så egendomligt, att man är betänksam inför de siffror, som nu framläggas från samma håll.

Man har gjort gällande — och den meningen har framskymtat även under dagens debatt här i kammaren — att praktiskt taget mycket stor enighet numera skulle råda bland sjukkassefolket därom, att det föreliggande förslaget borde antagas av riksdagen. För inte så många dar sedan lät en här i Stockholm verksam propagandacentral publicera ett statistiskt sammandrag av opinionsrörelsens resultat, och det påstods i detta dokument, att en överväldigande majoritet bland kassornas medlemmar skulle ha gett sin anslutning till det kungl. förslaget, under det att endast ett relativt litet fåtal skulle ha givit tillkänna en motsatt uppfattning.

När man tar del av dessa uppgifter, måste man medge, att det är med statistiken alldeles som

med kråkan i den gamla folkvisan: den är nyttig till mången god ting. Det verkliga förhållandet är, att man räknat propositionens anhängare respektive motståndare efter en mycket fintlig, men långt ifrån korrekt metod. Man har inte kunnat komma ifrån den tråkiga omständigheten, att en mängd kassor protesterat mot propositionen, däribland två stora rikssjukkassor med sammanlagt över 100,000 medlemmar samt talrika större eller mindre

lokala kassor i olika delar av landet, varibland märkas 17 Stockholmskassor med sammanlagt över 19,000 medlemmar, 17 kassor, som på något sätt utgöra ett slags koalition och som gemensamt framträda inför allmänheten. Alla dessa protesterande kassor redovisas naturligtvis inom vederbörlig kolumn, men därmed är det också slut med offren på sanningens altare. Alla, som inte uttryckligen tillkännagivit en från det kungl. förslaget avvikande mening, presenteras helt frankt såsom förslagets anhängare, och detta vare sig de överhuvud taget uttalat någon mening eller inte. På det sättet är det ju mycket lätt att få till stånd en överväldigande majoritet, men om man underkastar själva primäruppgifterna en kritisk granskning, blir man inte nämnvärt imponerad av det resultat, som propagandacentralen kunnat framlägga.

En mycket erfaren sjukkasseman påstår, att sannolikt två tredjedelar av landets sjukkassefolk äro emot det föreliggande förslaget. Det är möjligt, att hans uppgift är något överdriven, och jag vill ingalunda åberopa den i syfte att framställa den såsom ett vittnesbörd om det verkliga förhållandet. Men det finns skäl, som tala för, att han kommit sanningen närmare än de, som påstå, att en utomordentligt stark majoritet ställt sig bakom propositionen. I själva verket vet ingen, vilkendera meningsriktningen som disponerar majoriteten, ty det enda man i detta sammanhang kan säga om det överväldigande flertalet sjukkassemedlemmar är, att detta flertal inte alls uttalat någon mening. Man vet inte vad det önskar eller icke önskar. Det finns ingen hållbar anledning att räkna dem vare sig till motståndarna eller till anhängarna — de utgöra helt enkelt en stor indifferent massa.

Till och med i sådana fall, då en kassa verkligen avlevererat en opinionsyttring, har man stundom orsak att titta litet närmare på sifferuppgifterna. Bland de kassor, som i propagandacentralens statistiska sammandrag redovisas i anhängarekolumnen, märkes en Stockholmskassa, vars hela medlemsantal är 24.000. Hur förhåller det sig nu med opinionsyttringen, när det gäller denna kassa? Jo, det förhåller sig på det sättet, att frågan om ett uttalande angående den föreslagna reformen upptogs till behandling på kassans årsmöte, men medlemmarna hade ingen aning om, att denna fråga skulle förekomma, ty styrelsen hade icke funnit opportunt att kungöra denna sak. Jag erinrar här återigen, att denna kassa räknar över 24,000 medlemmar. Resultatet blev, att mötet med 19 röster mot 18 antog ett av styrelsen enhälligt föreslaget uttalande till förmån för den kungl. propositionen. Det är sålunda dessa 19, som representera de 24,000 medlemmarna, under det att de 18, som haft en annan uppfattning och tillkännagivit den, ingenting betyda, när det gäller att räkna antalet anhängare respektive motståndare till reformen. Det förefaller mig, som om man inte hade anledning fästa alltför mycket avseende vid en opinion, som mobiliserats efter dylika

metoder.

Nu kan det ju naturligtvis tänkas, att man gått tillväga på samma sätt i andra fall, där kassorna uttalat en annan mening och protesterat mot det kungl. förslaget. Det vill jag inte bestrida; men jag får säga, att i så många fall, som Jag känner till, ligger saken på det sättet, att man har vederbörligen annonserat, att denna fråga skulle föreligga på mötena, och då har det ju varit möjligt för medlemmarna att på förhand skaffa sig kännedom om vad som förbereddes.

Ja, herr talman, jag har med detta velat i någon mån ange, varför den nu föreslagna reformen förefaller många betänklig. Man är helt enkelt rädd för, att den skall medföra sådana konsekvenser, att sjukförsäkringsverksamheten här i landet försvagas 1 stället för att stärkas. Och med all säkerhet kommer detta att bli fallet i sådana glest befolkade landsdelar, där det visat sig, att en lokal sjukkasseverksamhet icke kan upprätthållas. Det finns en mängd kommuner i landet, där endast lokala avdelningar av rikssjukkassorna äro i

verksamhet, och varför är det på det sättet? Jo, därför att rikssjukkassorna utgöra förträffliga rTiskutjämningsapparater. Man känner med sig, att på dessa glest befolkade trakter är det inte möjligt att upprätthålla en lokal sjukkasseverksamhet, som i väsentlig utsträckning skall bära sina egna risker. Det finns mycket lärorika statistiska uppgifter om denna sak, och de visa, att rikssjukkassorna regelbundet måste år efter år till lokalavdelningar i dylika trakter utbetala avsevärda riskutjämningsbelopp, och man förstår ju då, att om denna möjlighet att fördela riskerna över ett betydligt större område upphör, skall det bliva ganska vanskligt att överhuvud taget upprätthålla någon sjukkasseverksamhet i dessa glest befolkade trakter. Man är sålunda rädd för att sjukförsäkringsverksamheten kommer att försvagas i stället för att förstärkas. Sjukkasserörelsen har inte förtjänat att behandlas på det sättet men väl har den förtjänat att erhålla ökat understöd av staten, givet på sådana villkor, att det inte behöver innebära, att verksamheten går sönder och försvagas.

På grund av de anförda skälen yrkar jag bifall till reservationen och sålunda avslag på utskottets förslag.

Jag vill emellertid tillägga, att jag skulle känt mig mera tillfredsställd med reservanternas förslag, därest dessa visat någon tillstymmelse till förståelse för den tanke, som jag utvecklat i min motion nr 216, nämligen att i propositionen förekommande bestämmelser om moderskapsförsäkring och moderskapsunderstöd borde inarbetas i den nuvarande lagen. Jag kan ju gärna bekänna, att det var först efter mycken tvekan, som jag väckte denna motion, därför att jag inte var alldeles övertygad om, att det skulle vara tekniskt möjligt att åstadkomma detta. Men efter konferens med mycket erfarna sjukkassemän och andra kom jag till den övertygelsen, att det inte behövde möta några oöverstigliga tekniska svårigheter. Den sak, som det här gäller, moderskapsförsäkring och moderskapsunderstöd, är enligt min uppfattning socialt mycket viktig, och jag ger **fröken²** Hesselgren fullkomligt rätt i vad **hon²**

sade om denna sak. Jag tror, att det skulle hava gjort ett mycket gott intryck, därest reservanterna visat sig förstå, hur viktig denna sak är, och huru angeläget det är att densamma inom kort finner sin lösning.

Emellertid anser jag inte att man kan acceptera ett i övrigt otillfredsställande förslag endast för att därigenom tillförsäkra sig den vinst, som det skulle innebära att få frågan om moderskapsförsäkringen löst. Det bör inte vara omöjligt att lösa den frågan i annat sammanhang och lösa den inom loppet av en ganska kort tid. Jag föreställer mig, att den mycket väl skulle Fanna vinna sin lösning inom den tid, som avsetts att förflyta, innan den föreslagna sjukkassereformen skall träda i full tillämpning.